

NS

WANDERLEY WILSON LOPES

IDADE: 67a8m.	PESO: 102	ALTURA: 167	PROFISSÃO: PM - aposent.
SINTOMAS: Sonolência / Irritabilidade / cansaço / Dor em m. III.			
QUEIXAS: Revolta no quicongo. - Reflexo gastr. / Azarco.			
MEDICAMENTOS: Dose 50 / Anicon / Pantoprazol / Indapen / Glifage / PNM (01/08)			
MÉDICO: Dr. Expedito Leitão			
EXERCÍCIO FÍSICO: Natação (2x) / Caminhada			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 8 ALMOÇO: 12-13 LANCHE: 16 JANTAR: 20			
HORA QUE DORME: 22 hr		HORA QUE ACORDA: 8hr	
COCHILLO ☒ SIM () NÃO 1:30		DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃO		- Dorme DLE	
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 1x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: IV	IAH: 55,0	SPO2: 77%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Hemio Inguinal (E).			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA arritmia			
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS ansiedade.			
↳ Escoliose / Bursite / N. Gálico			
04/08 Locação de CPAP			
23 maio.			
11/08	P = 8,9 cmH ₂ O	Relata melhora	
23	IAH = 6,6 e lev.	da disposição, passou	
	M. de uso: 6h27'	de tomar med. p/	
	Fuga = 36,5 l/min.	dor muc. - fua	
18/08	P = 7,8 cmH ₂ O		
23	IAH = 4,0 e lev		
	m. de uso: 5h41'		
	Fuga = 7,7 med / Perc. 23,5	fua	
05/09	P = 8 cmH ₂ O	- Oriento p/ beber água	
23	M. de uso: 5m	-	
	IAH = 4,2 e lev		
	Fuga = 37,5 l/min.	fua.	
26/09	P = 8 cmH ₂ O		
23	IAH = 4,0 e lev		
	m. de uso: 4m		
	Fuga = 40 l/min	fua.	
24/10/23	P = 8 cmH ₂ O	- Boca seca - micopare	
	IAH = 3,9		
	Fuga = 36 l/min		
	m. de uso = 5h49 min		

08/10

SN 22222 083814 / 866 elite

DN

Bem adapt.

23/11
23 P= 8 cmH₂O
IAH= 2,9 e/ev
m. de uso: 2h42'

lua

18/03
24 P= 8 cmH₂O
IAH= 9,5 e/ev
m. de uso: 2h45'
fuga= 11.3 lpm.

{ 2x natação
2x caminhada 20'

18/04
24 P= 8 cmH₂O
IAH= 2,4 e/ev
m. de uso: 6h27min
fuga: 5,5 lpm

mantém atividade física
Bem adaptado
Natacha

13/06
24 P= 8 cmH₂O
m. de uso: 4h37'
IAH= 3,2 e/ev
fuga= 16.3 lpm.

Sertralina 50mg.

lua

03/10
24 P= 8 cmH₂O
IAH= 2,9 e/ev
m. de uso: 5h13'
fuga: 8,9 lpm.

Relata melhora da qualidade do sono e os sintomas melhoraram

lua

05/10/24 P= 8 cmH₂O
IAH= 3,8 e/ev
m. de uso= 4h40min
fuga= 26 l/min

FC: 110 bpm
SpO₂: 93%

Amloron / Indapen / Losartana
Está ótima

13/02
25 P= 8 cmH₂O
IAH= 6,2 e/ev
m. de uso: 3h48'
fuga= 27.6 lpm.

Bem adaptado, porém não consegue manter muitas horas de sono.

lua

08/04/25 P= 8 cmH₂O
IAH= 5,7 e/ev
m. de uso: 6h58'
fuga: 22,9 l/min

Bem adaptado, conseguiu dormir mais tempo ci apaucho

Natacha

CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

PSIQUIATRIA

CRM-SP 69.730

CRM-SP 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Wanderley Wilson Lopes

EXAME nº: 5376

SOLICITADO POR: Dr. Marcelo Priante Pintos

DATA: 03/05/2023

IDADE: 67 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h08min e concluído às 04h40min – ele saiu da cama mais tarde. A latência para o sono foi de 49 minutos e a latência para o estágio REM, de 400 minutos. O tempo total de sono foi de 207 minutos (03h27min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 45,7%. A distribuição do sono registrado mostrou 24,2% de estágio 1, 74,6% de estágio 2, 0% de estágio 3 e 1,2% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 197 minutos em vigília, ocorreram 66 microdespertares (índice: 19,1/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 55,4/hora, sendo 1,5 apneia/hora e 53,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 60,6/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 88%, sendo a média de 91% e a mínima de 77%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (55,4/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (60,6/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e eventos de arritmia cardíaca. As frequências cardíacas foram: mínima: 74; máxima: 94 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.
Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente demorou a adormecer (latência para o sono: 49 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (400 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 45,7%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 19,1/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (24,2%; normal: 8-10%) e 2 (74,6%; normal: 45-55%), e a redução do estágio REM (1,2%; normal: 20%). Ausência do estágio 3 (0%; normal: 10-12%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 15 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730